

Mity vs fakty

Mity utrudniają leczenie. „Tylko dziewczyny”, „wybór”, „mniej poważne niż anoreksja” — każdy z tych mitów ma realny koszt: opóźnienie pomocy, wstyd, izolację. Konfrontacja z faktami.

CZAS: 15 min Sesja 1–3 · psychoedukacja bliskich

ŹRÓDŁO: Bulik (2017, „Reframing Anorexia”); NEDA; BEAT; Fairburn (2008)

JAK UŻYWAĆ

Skonfrontuj **pięć najczęstszych mitów** o bulimii z faktami opartymi na badaniach (sekcja 1) i poznaj **trzy dodatkowe** kosztowne mity (sekcja 2). Sekcja 3 — **karta do rozmowy** z bliskimi. Sekcja 4 — własne refleksje.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Wokół bulimii narosła siatka mitów — w rodzinie, mediach, a czasem nawet wśród profesjonalistów (lekarze rodzinni, nauczyciele). Bulik (2017): mity są **nie tylko** niewiedzą — są **aktywną szkodą**. Każdy mit ma **realny koszt**: „*tylko dziewczyny*” → mężczyźni nie szukają pomocy; „*to wybór*” → samokrytyka i samostygma; „*mniej poważne niż anoreksja*” → odraczanie leczenia; „*wystarczy zjeść*” → frustracja rodziny i wycofanie wsparcia. Destygmatyzacja zaczyna się od **obalania mitów** — najpierw u siebie (wewnętrzny krytyk), potem w rozmowie z bliskimi i klinicystą. Konfrontacja z faktami opartymi na badaniach **zmniejsza** wstyd i **zwiększa** motywację do leczenia (NEDA, materiały edukacyjne; BEAT, kampanie świadomościowe).

01 = Pięć najczęstszych mitów

⊗ MIT · „TYLKO DZIEWCZYNINY”

„To choroba nastolatek”. Stereotyp wciąż dominujący w mediach.

✓ FAKT

20–25% wszystkich BN to mężczyźni (Hudson 2007). Początek najczęściej 18–25 lat, ale zaburzenie może wystąpić w każdym wieku.

⊗ MIT · „CHODZI TYLKO O WAGĘ”

„Wystarczy zaakceptować ciało i przejdzie”. Spłaszczanie do estetyki.

✓ FAKT

BN to *regulacja emocji* przez jedzenie. Waga jest często **powierzchnią**, pod którą jest lęk, kontrola, samoocena, trauma.

⊗ MIT · „TO WYBÓR, KWESTIA SILNEJ WOLI”

„Wystarczy chcieć przestać”. Najbardziej szkodliwy mit — generuje samokrytykę i wstyd.

✓ FAKT

Bulik (2007): 50–60% odziedziczalność. To *neurobiologiczne* zaburzenie z silnym komponentem genetycznym. **Nikt nie wybiera** bulimii.

⊗ MIT · „MNIEJ POWAŻNE NIŻ ANOREKSJA”

„BN to lżejsza wersja AN”. Skutek: odraczanie leczenia, bagatelizowanie.

✓ FAKT

Mitchell (2016): śmiertelność standaryzowana BN = 1,93 — prawie 2× wyższe ryzyko zgonu. *Inne przyczyny* niż w AN (głównie arytmie i samobójstwa), ale równie poważne.

⊗ MIT · „NIE DA SIĘ Z TEGO WYJŚĆ”

„Bulimia jest nieuleczalna”. Fatalizm.

✓ FAKT

Fairburn i in. (2009): CBT-E daje pełną remisję u **40–60%** pacjentów z BN. Wczesne leczenie — 70%. BN to choroba *leczalna*.

02 = Trzy kolejne kosztowne mity

❌ „TRZEBA BYĆ CHUDĄ”

„Mam normalne BMI, więc nie mogę mieć bulimii”.

✓ FAKT

BN cechuje się BMI w normie lub nadwadze. Niski BMI = AN, nie BN. Większość osób z BN wygląda zdrowo.

❌ „TO PRÓŻNOŚĆ”

„Dziewczyny dbają tylko o wygląd”.

✓ FAKT

Próżność dotyczy celebrowania wyglądu. ED to przeciwieństwo — cierpienie z powodu wyglądu, ucieczka w kontrolę.

❌ „OSOBY Z BULIMIĄ KŁAMIĄ”

„Nie można im wierzyć, ukrywają”.

✓ FAKT

Ukrywanie wynika ze **wstydu**, nie złej woli. To objaw bulimii. Pacjenci sami cierpią z powodu sekretu — rozumiejący odbiorca pomaga go przerwać.

03 💡 Karta do rozmowy z bliskimi

Gdy ktoś bliski mówi coś, co utrwała mit — warto mieć przygotowaną krótką odpowiedź. Nie po to, by się sprzeczać, ale by chronić siebie i normalizować chorobę. Trzy zdania wystarczą.

Wzór 3 zdań: „To, co opisujesz, to popularny mit. Faktycznie [krótka informacja oparta na badaniach]. Wolę nie rozmawiać o tym w taki sposób — czy możemy zmienić temat?”

Przykład: „To popularny mit, że BN to wybór. Faktycznie ma 50-60% odziedziczalności. Wolę, żebyś nie używał/-a słów „silna wola” w tym kontekście — to mi nie pomaga.”

04 ✎ Moje refleksje

KTÓRY MIT NAJMOCNIEJ ŻYŁ WE MNIE

— jak wpływał na moje myśli o sobie i decyzje o leczeniu

Klucz: mity o bulimii są *aktywną szkodą* — nie tylko niewiedzą. Każdy z nich ma **realny koszt**: opóźnienie leczenia, wstyd, izolację, samokrytykę. Konfrontacja z faktami zaczyna się od siebie — rozpoznać, które mity *internalizujesz* i jak wpływają na Twoje myśli o sobie. Następnie — rozmowa z bliskimi i klinicystą. Bulik (2017, „Reframing Anorexia”): destygmatyzacja jest **warunkiem** skutecznego leczenia — pacjent w środowisku wolnym od mitów ma istotnie wyższą motywację, zaangażowanie i wyniki. NEDA i BEAT prowadzą kampanie świadomościowe, polskie organizacje (np. Centrum Terapii i Profilaktyki Zaburzeń Odżywiania) — podobnie. Jeśli rozpoznajesz u siebie te mity, *nie* jesteś winny/-a — żyjemy w kulturze, która je propaguje. **Pierwszy krok:** świadomość. Drugi — zmiana wewnętrznego dialogu. Trzeci — rozmowa z bliskimi.